

Suivi d'une Hépatopathie chronique / Cirrhose

ESMS | Biologie utile, surveillance CHC et pièges à éviter

Distinguer trois situations

- **Hépatopathie chronique sans cirrhose** : fréquence selon l'étiologie et le traitement.
- **Cirrhose** : surveillance clinique, biologique et carcinologique structurée.
- **Insuffisance hépatique décompensée** : rythme individualisé / spécialisé.

Biologie - cirrhose / insuffisance hépatocellulaire

- | | |
|---------------------|--|
| • NFS-plaquettes | • Na, K |
| • TP / INR | • Créatinine + DFG |
| • Albuminémie | • ASAT/ALAT, PAL/GGT selon étiologie et activité |
| • Bilirubine totale | |

Fréquence pratique

- **Cirrhose compensée stable** : souvent tous les 6 à 12 mois selon étiologie, antécédents et suivi spécialisé.
- **Décompensation, ascite, diurétiques, hyponatrémie, atteinte rénale** : rapprocher nettement, souvent 1 à 3 mois ou selon spécialiste.
- Pas de fréquence biologique unique valable pour toutes les cirrhoses.

Surveillance CHC

- Échographie hépatique tous les 6 mois chez les patients cirrhotiques éligibles à une prise en charge curative.
- AFP : selon EASL 2024, ajout possible pour augmenter la sensibilité au prix d'une moindre spécificité; ce n'est pas un dosage obligatoire isolé.

À ne pas faire en routine

- **Ammoniémie** : ne pas utiliser comme test de surveillance systématique d'un patient stable.
- À réserver à des situations cliniques ciblées, en lien avec le tableau neurologique et le contexte.